

Datei: emails/2026-04-05_probst_an_qualitaetsmanagement_rampe.eml

Von	jana.probst@moisellogistik.example.invalid
An	qualitaetsmanagement@moisellogistik.example.invalid
Datum	Sun, 05 Apr 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Vorfall Rampe 4 - bitte vorsichtig formulieren

Hallo zusammen,

zum Vorfall mit Herrn Moeller an Rampe 4 bitte ich, die Unfallanzeige vorsichtig zu formulieren. Die Rampe war seit Maerz immer wieder schwergaengig, das steht auch im Wartungsbuch. Der Techniker war fuer den 8. April angekuendigt.

Bitte diesen Punkt intern behalten und nicht unnoetig in den Vordergrund stellen, wenn die BG anfragt.

Viele Gruesse
Jana Probst
Betriebsleiterin

Datei: emails/2026-04-11_klinik_an_kanzlei_mrt_befund.eml

Von	sekretariat.unfallchirurgie@bruederkrankenhaus-trier.example.invalid
An	kanzlei-lindenhof@example.invalid
Datum	Sat, 11 Apr 2026 10:05:00 +0200
Betreff	MRT-Befund Herr Moeller vom 09.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei wie telefonisch besprochen der MRT-Befund von Herrn Karsten Moeller vom 09.04.2026 sowie der aktuelle Zwischenbericht des Durchgangsarztes Dr. Kauth. Bei Rueckfragen stehen wir gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen
Sekretariat Unfallchirurgie
Bruederkrankenhaus Trier

Datei: eml/2026-06-23_kanzlei_an_mandant_bescheid_eingegangen.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Tue, 23 Jun 2026 09:30:00 +0200
Betreff	Ablehnungsbescheid der BG ist eingegangen

Sehr geehrter Herr Moeller,

der Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft vom 18.06.2026 ist bei uns eingegangen. Die Widerspruchsfrist laeuft bis zum 22.07.2026. Wir werden fristgerecht Widerspruch einlegen und benoetigen dafuer noch die Anschriften der beiden Zeugen Herr Kopp und Frau Lehnert.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Nadine Ohlerich

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen unfallversicherung-arbeitsunfall-lagerleiter-sturz-trier

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: eml/2026-10-21_kanzlei_an_mandant_klage_eingereicht.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Wed, 21 Oct 2026 14:12:00 +0200
Betreff	Klage beim Sozialgericht Trier eingereicht

Sehr geehrter Herr Moeller,

wir haben gestern die Klageschrift beim Sozialgericht Trier eingereicht. Das Aktenzeichen wird voraussichtlich in den naechsten Tagen mitgeteilt. Wir halten Sie ueber den weiteren Fortgang auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Nadine Ohlerich

Datei: 07_verletztengeld_und_lohn.csv

monat	brutto_arbeitgeber	krankengeld_berechn	bg_verletztengeld_of	notiz
2026-04	4180	0	offen	Entgeltfortzahlung läuft
2026-05	4180	2860	streitig	BG-Ablehnung belastet Zahlung
2026-06	4180	2860	streitig	Reha-Antrag erwogen
2026-07	4180	2860	streitig	Widerspruchsmonat

Datei: 32_fristenkalender_verfahren.csv

datum	ereignis	frist_ablauf	status
2026-04-03	Unfallereignis Rampe 4		erledigt
2026-04-08	Unfallanzeige Arbeitgeber an BG		erledigt
2026-04-21	Operation Rotatorenmanschette		erledigt
2026-05-06	Akteneinsicht BG gewaehrt		erledigt
2026-05-28	Anhoerungsschreiben BG	2026-06-11	erledigt
2026-06-18	Ablehnungsbescheid BG	2026-07-22	erledigt
2026-06-22	Zugang Ablehnungsbescheid	2026-07-22	erledigt
2026-07-20	Widerspruch eingelegt		erledigt
2026-09-25	Widerspruchsbescheid BG	2026-10-25	erledigt
2026-10-20	Klageschrift Sozialgericht Trier		erledigt
2026-11-25	Klageerwiderung BG		erledigt
2027-01-08	Ambulante Untersuchung durch Sachverstaendigen		erledigt
2027-01-14	Sachverstaendigengutachten vorgelegt		erledigt
2027-03-15	Erwartete muendliche Verhandlung Sozialgericht Trier		offen
2028-01-14	Empfohlene MdE-Nachuntersuchung		offen

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt	Status	Warum wichtig	Nächster Output
Bescheidzugang	prüfen	Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig	Fristkalender
medizinischer Kernbefund	prüfen	Arztbrief, Gutachten, Pflegeprotokoll	Belegmatrix
Eilbedürftigkeit	prüfen	Kosten, Gesundheitsrisiko, Versorgungslücke	Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Datei: csv/arbeitsunfaehigkeitszeiten.csv

zeitraum	status	bemerkung
2026-04-03_bis_2026-04-16	arbeitsunfaehig	Erstbescheinigung Durchgangsarzt
2026-04-17_bis_2026-05-14	arbeitsunfaehig	Verlaengerung nach MRT und OP-Planung
2026-05-15_bis_2026-06-22	arbeitsunfaehig	postoperativ und stationaere Reha
2026-06-23_bis_2026-07-31	arbeitsunfaehig	ambulante Physiotherapie
2026-08-01_bis_2026-09-25	teilweise_arbeitsfaehig	geplante Wiedereingliederung ausgesetzt

Datei: csv/wartungsbuch_rampe4_auszug.csv

datum	eintrag	eingetragen_von
2026-03-02	Ueberladebruecke Rampe 4 laeuft schwer beim Ausfahren	Herbert Nauheim
2026-03-15	Bruecke Rampe 4 erneut schwergaengig gemeldet	Herbert Nauheim
2026-03-28	Hydraulikzylinder Rampe 4 bestellt Ersatzteil ausstehend	Herbert Nauheim
2026-03-30	Provisorische Nachfettung Rampe 4 bis Ersatzteil eintrifft	Herbert Nauheim
2026-04-08	Technikertermin Rampe 4 geplant	Herbert Nauheim

Tabellenblatt: Verletztengeld-AAW

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Monat

Bruttoarbeitsentgelt

Regelentgelt kalendertaeglich

Verletztengeld 80 Prozent Brutto

Verletztengeld kalendertaeglich

Nettoarbeitsentgelt Vergleich

Bemerkung

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

April 2026 (bis 03.04.)

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Entgeltfortzahlung bis 03.04., danach Verletztengeld ab 15.05.

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Mai 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Entgeltfortzahlung 6 Wochen bis 14.05., danach Verletztengeld

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Juni 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Verletztengeld streitig wegen Ablehnungsbescheid

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Juli 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Widerspruchsmonat, Zahlung ausgesetzt

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

August 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Weiterhin ausgesetzt bis Widerspruchsbescheid

Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Hinweis: Verletztengeld betraegt 80 Prozent des Regelentgelts, gedeckelt auf das Nettoarbeitsentgelt (Paragraf 47 SGB VII). Die Berechnung ist vorlaeufig und wurde mangels Anerkennung als Arbeitsunfall bislang nicht ausgezahlt.

Tabellenblatt: MdE-Berechnung

Einschaetzung der Minderung der Erwerbsfaehigkeit (MdE)			
Funktionsbereich	Befund	Vergleichswert unfallmedizinische Tabelle	Einzel-MdE

Einschaetzung der Minderung der Erwerbsfaehigkeit (MdE)			
Aktive Abduktion rechts	150 Grad, Kraftgrad 4 von 5	Verlust der Armhebefaehigkeit ueber Schulterhoehe bei sonst freier Beweglichkeit 20 bis 30 vom Hundert	20 vom Hundert
Aussenrotation	endgradig schmerzhaft eingeschraenkt	geringe zusaetzliche Funktionsminderung	kein Zuschlag, in Gesamtwert eingerechnet
Kraftminderung Gesamtarml	leicht reduziert im Seitenvergleich	keine eigenstaendige Erhoehung	kein Zuschlag
Gutachterliche Gesamt-MdE (vorlaeufig)			20 vom Hundert
Hinweis: Eine MdE von mindestens 20 vom Hundert ueber die 26. Woche nach dem Arbeitsunfall hinaus begruendet dem Grunde nach einen Anspruch auf Verletztenrente nach Paragraf 56 SGB VII. Eine Nachuntersuchung nach zwei Monaten wurde vom Sachverstaendigen empfohlen.			

Tabellenblatt: Rentenberechnung-Unfallrente

Vorlaeufige Berechnung der Verletztenrente		
Berechnungsgroesse	Wert	Erlaeuterung
Jahresarbeitsverdienst (JAV)	50160 Euro	Bruttojahresverdienst der zwei Monate vor dem Unfall, 12 mal 4180 Euro
MdE	20 vom Hundert	Vorlaeufige gutachterliche Einschaetzung
Vollrente (bei MdE 100)	33440 Euro pro Jahr	Zwei Drittel des JAV nach Paragraf 56 Absatz 3 SGB VII
Teilrente bei MdE 20	6688 Euro pro Jahr	20 vom Hundert der Vollrente
Monatliche Teilrente	557.33 Euro	Teilrente geteilt durch zwei Monate
Hinweis: Die Berechnung ist eine rentenberaterliche Modellrechnung auf Grundlage der vorlaeufigen MdE-Einschaetzung von 20 vom Hundert und dient der Vorbereitung des Klageverfahrens. Endgueltig entscheidet die Berufsgenossenschaft beziehungsweise das Sozialgericht nach Vorliegen der Nachuntersuchung.		

Tabellenblatt: Fehlzeiten-Uebersicht

Fehlzeitenuebersicht Karsten Moeller, 2016 bis 2026			
Jahr	Fehltage gesamt	davon schulterbezogen	Bemerkung
2016	3	2	Schulterbeschwerden nach Handball, kurzfristig
2017	2	2	Erneute kurze Schonung nach Sport
2018	1	1	Letzte schulterbezogene Fehlzeit vor dem Unfall
2019	4	0	Grippaler Infekt, keine Schulterbeschwerden
2020	0	0	Keine Fehltage
2021	2	0	Grippaler Infekt
2022	0	0	Keine Fehltage
2023	1	0	Zahnbehandlung
2024	0	0	Keine Fehltage, Vorsorgeuntersuchung uneingeschraenkt tauglich
2025	0	0	Keine Fehltage
2026	68	68	Ab 03.04.2026 durchgehend wegen Unfallereignis
Hinweis: Zwischen 2019 und dem Unfalltag 2026 gab es keine einzige schulterbezogene Fehlzeit, was die betriebliche Beschwerdefreiheit in den letzten sieben Jahren vor dem Ereignis belegt.			

Mandatsnotiz BG-Fristsache

1. Mandant

Mandant ist Karsten Möller, geboren am 19.08.1971, Lagerleiter bei MoselLogistik GmbH, Hafenstraße 28, 54293 Trier. Beschäftigt seit 2011, zuletzt Schichtverantwortlicher für Wareneingang und Ladungssicherung.

2. Ereignis

Am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr stürzte der Mandant an Rampe 4 beim Zurückziehen einer verklemmten Überladebrücke. Er schlug mit rechter Schulter und Kopfkante auf den Betonboden. Der Staplerfahrer Bastian Kopp sah den Sturz nicht direkt, hörte aber den Aufprall. Kamera Rampe 4 fiel nach Angaben des Arbeitgebers zwischen 6:30 und 7:10 Uhr aus.

3. Streitstand

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte mit Bescheid vom 18.06.2026 die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Begründung: kein nachgewiesenes äußeres Ereignis, degenerativer Vorschaden der rechten Schulter, mögliches Ausrutschen ohne betriebliche Ursache. Zugang am 22.06.2026, Widerspruchsfrist bis 22.07.2026.

4. Rentenberaterlicher Fokus

Arbeitsunfallanerkennung, Heilbehandlung, Verletztengeld, mögliche Minderung der Erwerbsfähigkeit und Schnittstelle zur späteren Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Vorwürfe gegen den Arbeitgeber und Schmerzensgeld werden nur als Abgrenzung notiert und nicht übernommen.

Unfallanzeige Arbeitgeber, Auszug

1. Betriebsangaben

MoselLogistik GmbH, Unternehmensnummer der Unfallversicherung liegt vor. Unfalltag 03.04.2026, Meldung an die Berufsgenossenschaft am 08.04.2026. Der Arbeitgeber meldet den Vorfall als Sturz bei Wartungs- und Sicherungsarbeit an Rampe 4.

2. Angaben zum Ablauf

Karsten Möller habe die Überladebrücke geprüft, weil ein LKW der Spedition Havelmann schief an der Rampe stand. Beim Lösen der Brücke habe er das Gleichgewicht verloren. Persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe. Keine Zeugen des genauen Sturzmoments.

3. Interner Nachtrag

In einer internen Mail vom 05.04.2026 schreibt Betriebsleiterin Jana Probst: "Bitte vorsichtig formulieren, Rampe war seit März immer wieder schwergängig." Dieser Satz fehlt in der an die BG gesendeten Unfallanzeige.

4. Offene Belege

Wartungsprotokoll Rampe 4, Kameraausfallprotokoll, Schichtplan, Unterweisung Ladungssicherung und Meldung an Fachkraft für Arbeitssicherheit anfordern.

Durchgangsarztbericht, Auszug

1. Erstbehandlung

Durchgangsarzt Dr. Reiner Kauth, Brüderkrankenhaus Trier, Untersuchung am 03.04.2026 um 8:15 Uhr.
Diagnose: Schulterprellung rechts, Verdacht Rotatorenmanschettenruptur, Schädelprellung ohne Bewusstlosigkeit, Schürfwunden rechter Ellenbogen.

2. Anamnese

Patient berichtet Sturz von Rampe bei der Arbeit. Kein Schwindel vor dem Sturz, keine Synkope. Schmerzen sofort in rechter Schulter, Armheben nicht möglich. Der Patient gibt an, er habe seit Jahren gelegentlich Schulterschmerzen nach Handball, aber nie Arbeitsunfähigkeit wegen Schulter gehabt.

3. Weiteres Vorgehen

MRT empfohlen, Arbeitsunfähigkeit zunächst bis 17.04.2026. D-Arzt vermerkt: Unfallzusammenhang möglich, Vorschaden abklärungsbedürftig. Bei bestätigter frischer Ruptur Wiedervorstellung in Unfallchirurgie.

MRT-Befund und Vorschadenstreit

1. MRT 09.04.2026

Teilruptur Supraspinatussehne rechts, subakromiale Flüssigkeit, Knochenmarködem am Tuberculum majus, degenerative AC-Gelenksarthrose. Radiologin Dr. Hage notiert: "Frische traumatische Komponente bei degenerativer Vorschädigung nicht ausgeschlossen."

2. Vorunterlagen

Hausarztakte 2018: Schulter rechts nach Handball, konservativ behandelt, keine Bildgebung. Keine AU länger als drei Tage. Betriebsärztliche Vorsorge 2024: volle Tauglichkeit für Lagerleitung, keine Einschränkung Heben bis 15 kg.

3. Streitfrage

Die BG liest den Befund als überwiegend degenerativ. Für den Widerspruch sind Erstschmerz, Sturzmechanik, Knochenmarködem, vorherige Beschwerdearmut und unmittelbare Funktionsminderung herauszuarbeiten. Zugleich darf der Vorschaden nicht verschwiegen werden.

Zeugennotizen und Kameraausfall

1. Bastian Kopp, Staplerfahrer

Kopp sah Möller um 6:40 Uhr an Rampe 4 mit Brecheisen an der Überladebrücke. Er fuhr Palette 112 in Halle C. Um 6:42 Uhr hörte er einen Schlag und fand Möller sitzend am Boden. Möller hielt die Schulter und sagte: "Die Brücke hat nachgegeben."

2. Sandra Lehnert, Disposition

Lehnert hörte über Funk: "Rampe 4 klemmt wieder." Sie kann nicht sagen, wer funkte. Im Wartungsbuch März steht dreimal "Brücke läuft schwer". Der Technikertermin war für 08.04.2026 geplant.

3. Kamera

IT-Vermerk: Kamera Rampe 4 verlor ab 6:31 Uhr Verbindung zum Switch. Wieder online 7:13 Uhr. Andere Kameras zeigen Möller um 6:38 Uhr auf dem Weg zur Rampe und Sanitäter um 7:02 Uhr.

4. Bedeutung

Der genaue Sturz ist nicht gefilmt. Die Indizienkette muss deshalb über betriebliche Tätigkeit, zeitlichen Ablauf, Erstangaben, technische Störung der Rampe und medizinischen Erstbefund geführt werden.

Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft

1. Entscheidung

Bescheid vom 18.06.2026: Anerkennung eines Arbeitsunfalls wird abgelehnt. Heilbehandlung über die gesetzliche Unfallversicherung wird nicht weiter übernommen. Rechtsbehelfsbelehrung mit Monatsfrist.

2. Begründung der BG

Ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper wirkendes Ereignis sei nicht im Vollbeweis nachgewiesen. Der Mandant sei allein gewesen. Die Schulterverletzung könne degenerativ entstanden sein. Ein betrieblicher Zusammenhang sei nicht ausreichend belegt, weil auch private Eigenbewegung möglich sei.

3. Auffälligkeiten

Der Bescheid erwähnt weder das Wartungsbuch noch die Erstangabe "Brücke hat nachgegeben". Die Kameraausfälle werden nicht gewürdigt. Der MRT-Befund wird verkürzt als degenerativ bezeichnet, ohne das Knochenmarködem zu diskutieren.

Widerspruchsentwurf gegen BG-Bescheid

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 18.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Anerkennung des Ereignisses vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall und die Übernahme der unfallbedingten Heilbehandlung einschließlich Prüfung von Verletztengeld.

2. Begründungskern

Der Mandant übte eine versicherte Tätigkeit aus, als er die klemmende Überladebrücke an Rampe 4 sicherte. Der Sturz war zeitlich begrenzt, wirkte von außen auf den Körper ein und führte zu sofort dokumentierten Gesundheitsschäden. Die BG hat wesentliche Indizien nicht ausgewertet: Erstangabe, Wartungsvermerke, Funkmeldung, Kameraausfall und MRT-Hinweise.

3. Beweisanträge

Beiziehung Wartungsbuch Rampe 4, Vernehmung Bastian Kopp und Sandra Lehnert, Einholung unfallchirurgischer Zusammenhangsbegutachtung, Beiziehung Betriebsarztakte und Kameraausfallprotokoll.

Folgeprüfung Verletztengeld, Teilhabe und Rente

1. Unfallversicherungsrechtliche Folgen

Bei Anerkennung sind Heilbehandlung, Verletztengeld, medizinische Rehabilitation und bei verbleibender Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Verletztenrente zu prüfen. Die Einschätzung darf nicht vorzeitig an der Schulterdiagnose hängen bleiben; entscheidend ist die konkrete Funktionsminderung im Lagerleiterberuf.

2. Rentenrechtliche Schnittstelle

Wenn die Arbeitsfähigkeit länger als sechs Monate offen bleibt, müssen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und eine spätere Erwerbsminderungsrente mitgedacht werden. Die Anerkennung als Arbeitsunfall kann medizinische und rentenrechtliche Beweisfragen beeinflussen, ersetzt aber nicht die Prüfung der Erwerbsfähigkeit nach SGB VI.

3. Nächste Schritte

Reha-Plan anfordern, Arbeitgeber zu leidensgerechtem Einsatz befragen, Schmerztagebuch nicht als Klagebegründung überladen, sondern nur zur Funktionseinbuße nutzen. Frist Widerspruch 22.07.2026 sichern.

Ausfuehrliche Unfallschilderung des Mandanten

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Fachanwaelte fuer Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Telefon 0651 145 7720, Telefax 0651 145 7721

USt-IdNr. DE 267 991 430

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich, Rechtsanwaeltin, Fachanwaeltin fuer Sozialrecht

1. Vorbemerkung

Die nachfolgende Schilderung wurde am 14.04.2026 im Rahmen eines rund neunzigminuetigen Mandantengespraechs in der Kanzlei aufgenommen und dem Mandanten Karsten Moeller anschliessend zur Durchsicht und Unterschrift vorgelegt. Sie ersetzt keine eidesstattliche Versicherung, dient aber als Grundlage fuer die Widerspruchsbegrueendung.

2. Tagesablauf vor dem Ereignis

Herr Moeller begann die Fruehschicht am 03.04.2026 um 6:00 Uhr mit der Uebergabe von Schichtleiter Dennis Auer. Auer berichtete, dass Rampe 4 bereits in der Nachtschicht Probleme beim Ausfahren der Ueberladebruecke gemacht habe und ein LKW der Spedition Havelmann seit 5:50 Uhr an Rampe 4 auf Entladung warte. Herr Moeller entschied sich, selbst nach Rampe 4 zu sehen, weil der zustaeendige Rampenwart erst ab 7:00 Uhr eingeteilt war.

3. Ablauf an der Rampe

Gegen 6:38 Uhr erreichte Herr Moeller Rampe 4. Die Ueberladebruecke stand schraeg und liess sich mit dem Hebel nicht vollstaendig ausfahren. Er stellte sich seitlich auf die Rampenkante, um mit beiden Haenden am Hebel Zug auszuueben. Nach eigener Erinnerung loeste sich der Widerstand ploetzlich, die Bruecke schnellte nach unten durch, und er verlor den Halt. Er stuerzte nach rechts vornueber auf den etwa 90 Zentimeter tiefer liegenden Hallenboden vor der Rampe.

3.1 Koerperhaltung beim Aufprall

Der Mandant beschreibt, dass er versucht habe, sich mit dem rechten Arm abzufangen, dabei aber mit der rechten Schulter zuerst aufgeschlagen sei; der Kopf habe die Betonkante der Rampenlippe im Nachgang gestreift. Er sei kurz benommen gewesen, habe aber nicht das Bewusstsein verloren.

3.2 Erste Reaktion

Er habe sofort laut nach Hilfe gerufen und dabei sinngemaess gesagt: 'Die Bruecke hat nachgegeben, die war schon wieder schwergaengig.' Diese Aussage deckt sich mit der spaeteren Zeugenangabe von Bastian Kopp.

4. Angaben zur Vorgeschichte der Schulter

Herr Moeller bestaetigt, in den Jahren 2016 bis 2018 gelegentlich nach Handballspielen Schulterbeschwerden rechts gehabt zu haben, die jeweils nach wenigen Tagen ohne Arztbesuch abgeklungen seien. Seit 2019 habe er keinen Leistungssport mehr betrieben und keinerlei Einschraenkung im Arbeitsalltag gehabt, was durch die betriebsaerztliche Untersuchung 2024 bestaetigt worden sei.

5. Angaben zur Arbeitsanweisung

Nach interner Arbeitsanweisung Nr. 14 zur Ladungssicherung ist eine klemmende Ueberladebruecke durch den Rampenwart und nicht durch den Lagerleiter zu warten. Herr Moeller raeumt ein, im Zeitdruck gegen diese Anweisung verstossen zu haben, weist aber darauf hin, dass Vorgesetzte wiederholt toleriert haetten, dass Schichtverantwortliche bei Personalengpaessen selbst eingriffen.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Unfallanzeige des Unternehmers, Formular BGHW, ausgefüllt

1. Angaben zum Unternehmen

2. Angaben zur versicherten Person

3. Angaben zum Unfallhergang

4. Unfallhergang laut Unternehmer

Der Versicherte habe beim Loesen einer klemmenden Ueberladebruecke an Rampe 4 das Gleichgewicht verloren und sei zu Boden gestuerzt. Zeugen des unmittelbaren Sturzes seien nicht vorhanden. Erste Hilfe sei durch die Sicherheitsbeauftragte vor Ort geleistet worden, anschliessend Transport durch den Rettungsdienst.

5. Angaben zu Verletzungen

Nach vorlaeufiger Einschaeztung: Schulterverletzung rechts, Schuerfwunden, Verdacht auf Kopfprellung. Erstbehandelnder Arzt: Dr. Reiner Kauth, Bruederkrankenhaus Trier, Durchgangsarzt.

6. Anmerkung der Kanzlei

Das Formular enthaelt in Feld 14 (Zusatzangaben) keinen Hinweis auf die Wartungshistorie der Rampe, obwohl diese dem Arbeitgeber nach dem Wartungsbuch bekannt war. Diese Luecke ist fuer die Beweiswuerdigung im Widerspruch bedeutsam.

Formathinweis: Dieses Aktenstueck wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschliesslich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Feld	Angabe
Unternehmen	MoselLogistik GmbH
Anschrift	Hafenstrasse 28, 54293 Trier
Mitgliedsnummer BGHW	350118
Betriebsstaette	Logistikzentrum Trier-Ehrang, Halle C
Zustaendige Berufsgenossenschaft	Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier

Feld	Angabe
Name	Karsten Moeller
Geburtsdatum	19.08.1971
Beschaeftigt seit	01.03.2011
Taetigkeit	Lagerleiter, Schichtverantwortlicher Wareneingang
Versicherungsnummer	65 190871 M 003

Feld	Angabe
Unfalltag	03.04.2026
Unfallzeit	gegen 6:42 Uhr
Unfallort	Rampe 4, Logistikzentrum Trier-Ehrang
Letzter Arbeitstag vor Meldung	03.04.2026
Datum der Anzeige	08.04.2026
Meldeweg	elektronisch ueber DGUV-Formularservice

Erste-Hilfe-Bericht der Sicherheitsbeauftragten

MoselLogistik GmbH

Arbeitssicherheit

Hafenstrasse 28, 54293 Trier

1. Angaben zur Ersthelferin

Sicherheitsbeauftragte und Ersthelferin: Petra Winkelmann, Fachkraft fuer Arbeitssicherheit im Nebenamt, seit 2015 im Betrieb. Sie wurde um 6:43 Uhr per Funk alarmiert und traf um 6:45 Uhr an Rampe 4 ein.

2. Vorgefundene Situation

Herr Moeller sass an der Rampenkante auf dem Hallenboden, hielt sich die rechte Schulter und wirkte laut Bericht blass und leicht desorientiert. Eine kleine Schuerfwunde am rechten Ellenbogen blutete leicht. Am Hinterkopf war eine geroetete Stelle ohne offene Wunde sichtbar.

3. Erste-Hilfe-Massnahmen

Stabile Seitenlage wurde nicht angewendet, da der Mandant ansprechbar war. Die Schuerfwunde wurde mit einem Verbandpaeckchen aus dem Verbandskasten Halle C versorgt. Der rechte Arm wurde behelfsmaessig mit einem Dreiecktuch ruhiggestellt. Um 6:47 Uhr erfolgte die Alarmierung des Rettungsdienstes ueber die Notrufnummer 112.

4. Aussage des Verletzten gegenueber der Ersthelferin

Frau Winkelmann notierte woertlich: 'Die Bruecke ist auf einmal durchgerutscht, ich konnte mich nicht mehr halten.' Diese Angabe wurde noch am selben Tag in das betriebliche Meldeblatt uebernommen.

5. Uebergabe an den Rettungsdienst

Der Rettungsdienst traf um 6:58 Uhr ein und uebernahm die weitere Versorgung. Frau Winkelmann uebergab die Kurzangaben zum Unfallhergang muendlich an den Rettungsassistenten.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Rettungsdienstprotokoll, Auszug

Rettungsdienst Trier-Saarburg

Einsatzprotokoll Nr. RD-2026-04-03-0142

1. Einsatzdaten

2. Erstbefund des Rettungsdienstes

Patient ansprechbar, orientiert zu Person, Ort und Zeit. Glasgow Coma Scale 15. Angabe starker Schmerzen in der rechten Schulter mit deutlich eingeschränkter Beweglichkeit. Kleine Schuerfwunde rechter Ellenbogen, gerötete druckschmerzhafter Stelle am Hinterkopf ohne neurologische Ausfälle.

3. Vitalparameter

4. Massnahmen

Anlage eines venösen Zugangs, Schmerzmedikation nach Rücksprache mit dem Notarzt, Ruhigstellung des rechten Arms mit Armschlinge, Immobilisation der Halswirbelsäule mit Stiffneck aus Vorsicht wegen Kopfanprall, liegender Transport in die Notaufnahme.

5. Fremdanamnese laut Protokoll

Betriebliche Ersthelferin gibt an, der Patient sei beim Lösen einer klemmenden Laderampe gestürzt. Patient selbst bestätigt gegenüber dem Rettungsdienst: 'Die Ueberladebrücke hat nachgegeben, ich bin nach vorne gefallen.'

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Feld		Angabe	
Alarmierung		03.04.2026, 6:47 Uhr	
Eintreffen am Einsatzort		03.04.2026, 6:58 Uhr	
Einsatzort		MoselLogistik GmbH, Hafenstrasse 28, Rampe 4	
Übergabe Krankenhaus		03.04.2026, 7:34 Uhr, Bräuerkrankenhaus Trier	
Zeit	Puls	Blutdruck	SpO2
7:00 Uhr	92	138/86	97 Prozent
7:15 Uhr	88	134/82	98 Prozent
7:30 Uhr	86	132/80	98 Prozent

Krankenhaus-Aufnahmebericht und Verlaufsbericht

Bruederkrankenhaus Trier

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopaedie

Nordallee 1, 54292 Trier

1. Aufnahme

Aufnahme in die Notaufnahme am 03.04.2026 um 7:34 Uhr durch den Rettungsdienst. Aufnehmender Arzt: Dr. Reiner Kauth, Durchgangsarzt. Diagnosen bei Aufnahme: Verdacht auf Rotatorenmanschettenruptur rechts, Schaedelprellung, Schuerfwunden rechter Ellenbogen.

2. Untersuchungsbefund

Rechte Schulter druckschmerzhaft, aktive Abduktion nicht ueber 30 Grad moeglich, passive Beweglichkeit endgradig eingeschraenkt und schmerzhaft. Kein neurologisches Defizit im Bereich des Plexus brachialis. Kopf: reizlose Kopfschwarte, keine Kalottenstufe tastbar, Pupillen isokor und lichtreagibel.

3. Bildgebung am Aufnahmetag

Roentgen Schulter rechts in zwei Ebenen: keine knoecherne Fraktur, keine Luxation, altersentsprechende AC-Gelenksveraenderungen. Craniales CT bei Verdacht auf Schaedel-Hirn-Trauma ersten Grades: keine intrakranielle Blutung, keine Kalottenfraktur.

4. Verlauf stationaer

Stationaere Aufnahme zur Ueberwachung bei Kopfanprall vom 03.04.2026 bis 04.04.2026. Neurologische Kontrollen unauffaellig. Entlassung am 04.04.2026 mit ambulanter Weiterbehandlung, Terminvereinbarung MRT Schulter und Wiedervorstellung in der Unfallchirurgie.

5. Ambulanter Verlauf bis Operation

Wiedervorstellung am 10.04.2026 nach MRT-Befund vom 09.04.2026. Bei bestaetigter Teilruptur der Supraspinatussehne mit zunehmenden Beschwerden und ausbleibender Besserung unter konservativer Behandlung wird die Indikation zur arthroskopischen Rekonstruktion gestellt. Aufklaerungsgespraech am 16.04.2026, Operationstermin 21.04.2026.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Operationsbericht, Auszug

Bruederkrankenhaus Trier

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopaedie

Nordallee 1, 54292 Trier

1. Eingriffsdaten

2. Operativer Befund

Intraoperativ zeigt sich eine partielle, gelenkseitige Ruptur der Supraspinatussehne mit frischem, blutig imbibiertem Randsaum, vereinbar mit einem akuten traumatischen Ereignis auf vorbestehender degenerativer Sehnenstruktur. Zusaetzlich maessige Bursitis subacromialis.

3. Operationsverlauf

Arthroskopischer Zugang ueber Standardportale, Debridement der Rupturzone, transossaeare Refixation mit zwei Fadenankern, subacromiale Dekompression mittels Acromioplastik. Intraoperativ kein Hinweis auf ausschliesslich degenerative Genese ohne akuten Anteil.

4. Postoperative Anordnung

Ruhigstellung im Abduktionskissen fuer sechs Wochen, fruehfunktionelle Physiotherapie ab dem dritten postoperativen Tag nach festem Schema, Wiedervorstellung nach zwei Wochen zur Wundkontrolle.

5. Anmerkung zur Zusammenhangsfrage

Der Operateur haelt in der Epikrise fest, dass der intraoperative Befund eine frische traumatische Komponente auf degenerativer Vorscheidung zeige und die Ruptur ohne das Sturzereignis nach seiner Einschaeztung nicht in diesem Ausmass und Zeitpunkt aufgetreten waere.

Formathinweis: Dieses Aktenstu ck wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschliesslich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Feld	Angabe
Operationsdatum	21.04.2026
Operateur	Dr. Felix Brandenburger, Oberarzt Unfallchirurgie
Anaesthesie	Interskalenaere Plexusblockade und Allgemeinanaesthesie
Diagnose	Teilruptur der Supraspinatussehne rechts, subacromiales Impingement
Eingriff	Arthroskopische Rotatorenmanschettennaht, subacromiale Dekompression

Roentgenbefunde im Verlauf, mit radiologischer Bewertung

Radiologische Praxis am Domfreihof

Dr. Simone Hage, Fachaerztin fuer Radiologie

Domfreihof 9, 54290 Trier

1. Roentgen Schulter rechts, 03.04.2026

Zwei Ebenen, angefertigt im Bruederkrankenhaus Trier am Aufnahmetag. Kein Frakturnachweis, keine Luxation. Acromioclaviculargelenk mit geringer Arthrose, Humeruskopf regelrecht positioniert. Beurteilung: keine knoecherne Verletzung, Weichteilbefund radiologisch nicht sicher beurteilbar.

2. Kontrollroentgen, 12.05.2026

Drei Wochen postoperativ. Fadenanker regelrecht lagegetreu, keine sekundaere Dislokation, Acromioplastik-Areal reizlos. Beurteilung: postoperativer Verlauf ohne Auffaelligkeiten.

3. Vergleich mit Voraufnahmen

Aeltere Roentgenaufnahmen der Schulter liegen nicht vor, da 2016 bis 2018 keine Bildgebung erfolgte. Dr. Hage weist ausdruecklich darauf hin, dass ein bildgebender Vorbefund zum direkten Vergleich fehlt und die Bewertung des Vorschadens daher auf der MRT-Morphologie und der Anamnese beruhen muss.

4. Zusammenfassende radiologische Einschaetzung

Nach Aktenlage und Bildbefund haelt Dr. Hage eine ausschliesslich degenerative Erklaerung fuer nicht zwingend, da das im MRT nachgewiesene Knochenmarkoedem am Tuberculum majus typischerweise Ausdruck einer akuten knoechernen Belastungsreaktion und kein Zeichen einer chronisch-degenerativen Veraenderung ist.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlic dezimaler Gliederung ausgegeben.

Reha-Verlaufsbericht BG-Klinik

BG Klinik Ludwigshafen

Abteilung Unfallchirurgische Rehabilitation

Ludwig-Guttmann-Strasse 13, 67071 Ludwigshafen am Rhein

1. Aufnahme zur Anschlussheilbehandlung

Aufnahme am 02.06.2026 zur dreiwöchigen stationären Anschlussheilbehandlung nach arthroskopischer Rotatorenmanschettennaht. Behandelnder Oberarzt: Dr. Katja Vollmer.

2. Therapieverlauf

Physiotherapeutische Bewegungsschule, Ergotherapie zur Kräftigung des Schultergürtels, Ergometertraining, arbeitsplatzbezogenes Belastungstraining mit Simulation von Hebe- und Zugbewegungen wie im Lagerbetrieb. Zwischenbefund nach zwei Wochen: aktive Abduktion bis 90 Grad, weiterhin endgradiges Kraftdefizit.

3. Sozialmedizinische Epikrise

Die Klinik stuft das Ereignis vom 03.04.2026 aus behandlungsseitiger Sicht als wesentliche Ursache der aktuellen Funktionsstörung ein, weist aber auf die vorbestehende degenerative Komponente als mitwirkenden Faktor hin. Für die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung sei die Abgrenzung zwischen Unfallfolge und Vorschaden gutachterlich zu klären.

4. Entlassungsempfehlung

Entlassung am 22.06.2026 mit ambulanter Fortführung der Physiotherapie zweimal wöchentlich, stufenweiser Wiedereingliederung nicht vor August 2026, keine Hebebelastung über 5 Kilogramm mit dem rechten Arm bis auf Weiteres.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Antrag auf Leistungen zur Berufshilfe

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Domfreihof 6, 54290 Trier

1. Antragsteller und Adressat

Antragsteller: Karsten Moeller, vertreten durch die unterzeichnende Kanzlei. Adressat: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier, Aktenzeichen BGHW-2026-350118-MOELLER.

2. Antrag

Es werden Leistungen zur Berufshilfe nach Paragraph 35 SGB VII beantragt, hilfsweise Leistungen zur medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation, fuer den Fall, dass eine Rueckkehr auf den bisherigen Arbeitsplatz als Lagerleiter mit koerperlich schwerer Taetigkeit dauerhaft nicht moeglich ist.

3. Begruendung

Nach dem Reha-Verlaufsbericht der BG Klinik Ludwigshafen vom 22.06.2026 besteht weiterhin ein relevantes Kraftdefizit der rechten Schulter. Der Arbeitsplatz als Lagerleiter erfordert regelmaessiges Heben und Ueberkopfarbeiten, die nach aertzlicher Einschaetzung derzeit nicht zumutbar sind. Es wird angeregt, eine innerbetriebliche Umsetzung in eine disponierende, ueberwiegend sitzende Taetigkeit zu pruefen, hilfsweise eine externe Qualifizierungsmassnahme.

4. Vorlaeufiger Vorbehalt

Der Antrag wird ausdruuecklich unter dem Vorbehalt gestellt, dass die BG das Ereignis vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall anerkennt. Sollte die Anerkennung verweigert bleiben, wird der Antrag als Eventualantrag fuer das Widerspruchsverfahren aufrechterhalten.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlicb dezimaler Gliederung ausgegeben.

Detaillierter Durchgangsarztbericht mit Nachbehandlungsverlauf

Bruederkrankenhaus Trier

Durchgangsarztpraxis Dr. Reiner Kauth

Nordallee 1, 54292 Trier

1. Erstvorstellung

Erstvorstellung am 03.04.2026 um 8:15 Uhr nach Verlegung aus der Notaufnahme. Diagnosen: Schulterprellung rechts mit Verdacht auf Rotatorenmanschettenruptur, Schaedelprellung ohne Bewusstlosigkeit, Schuerfwunden rechter Ellenbogen. Arbeitsunfaehigkeit ab 03.04.2026.

2. Verlaufskontrollen

3. Zusammenhangsbeurteilung des Durchgangsarztes

Dr. Kauth haelt in seinem Zwischenbericht vom 30.06.2026 fest, dass der geschilderte Unfallmechanismus, der intraoperative Befund eines frischen Rupturrandes sowie der zeitliche Zusammenhang zwischen Ereignis und Erstschmerz fuer eine wesentliche Teilursache des Unfalls sprechen. Der Vorschaden werde dadurch nicht bestritten, trete aber nach seiner fachaeztlichen Einschaeztung in der Gesamtwuerdigung in den Hintergrund.

4. Arbeitsfaehigkeitsprognose

Bei planmaessigem Verlauf wird eine Wiederaufnahme leichter Buerotaetigkeiten ab August 2026 fuer moeglich gehalten, eine vollstaendige Rueckkehr zur urspruenglichen koerperlich schweren Lagerleitertaetigkeit ist nach jetzigem Stand ungewiss und haengt vom Ergebnis der Anschlussuntersuchung im September 2026 ab.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Datum	Befund	Massnahme
10.04.2026	MRT bestaetigt Teilruptur Supraspinatussehne	Operationsindikation gestellt
16.04.2026	Aufklaerung, praeoperative Diagnostik	OP-Termin 21.04.2026 vereinbart
05.05.2026	Zwei Wochen postoperativ, reizlose Wundverhaeltnisse	Physiotherapie fortgesetzt
02.06.2026	Beginn stationaere Anschlussheilbehandlung	Ueberweisung BG Klinik Ludwigshafen
30.06.2026	Nach Reha, Kraftdefizit rueckläufig, Abduktion 110 Grad	Stufenweise Wiedereingliederung geplant

Zeugenprotokolle mit Anschriften

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Loebstrasse 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MOELLER

1. Zeugenprotokoll Bastian Kopp

Bastian Kopp, geboren 04.02.1988, wohnhaft Zurmaiener Strasse 88, 54292 Trier, Staplerfahrer bei MoselLogistik GmbH seit 2019. Vernehmung am 20.04.2026 durch die BG-Aussendienstmitarbeiterin Frau Corinna Radtke.

Aussage: 'Ich habe Herrn Moeller gegen 6:38 Uhr auf dem Weg zu Rampe 4 gesehen, mit einem Brecheisen in der Hand. Ich bin dann mit Palette 112 in Halle C weitergefahren. Um etwa 6:42 Uhr habe ich einen lauten Schlag gehoert, der von Rampe 4 kam. Als ich hingefahren bin, sass Herr Moeller auf dem Boden und hielt sich die Schulter. Er hat gesagt, die Bruecke haette nachgegeben.'

2. Zeugenprotokoll Sandra Lehnert

Sandra Lehnert, geboren 17.11.1979, wohnhaft Kaiserstrasse 41, 54290 Trier, Disponentin bei MoselLogistik GmbH seit 2013. Vernehmung am 20.04.2026, ebenfalls durch Frau Radtke.

Aussage: 'Um kurz vor 6:40 Uhr kam ueber Funk die Meldung: Rampe 4 klemmt wieder. Ich kann nicht mehr sagen, wer das gefunkt hat, ich glaube aber, es war entweder Herr Moeller selbst oder der Staplerfahrer Kopp. Im Wartungsbuch fuer Maerz stehen mindestens drei Eintraege zur schwergaengigen Bruecke an Rampe 4. Ein Techniker war fuer den 8. April angekuendigt.'

3. Ergaenzende dritte Auskunftsperson

Rampenwart Herbert Nauheim, geboren 22.06.1965, wohnhaft Weberbach 3, 54290 Trier, gibt schriftlich an, dass er die Ueberladebruecke an Rampe 4 zuletzt am 30.03.2026 provisorisch nachgefettet habe, weil das Ersatzteil fuer den Hydraulikzylinder noch nicht eingetroffen sei. Er habe die Betriebsleitung mehrfach muendlich auf den Zustand hingewiesen.

4. Wuerdigung durch die Kanzlei

Alle drei Aussagen stuetzen unabhaengig voneinander, dass die Ueberladebruecke an Rampe 4 im relevanten Zeitraum technisch auffaellig war und dass Herr Moeller sich unmittelbar nach dem Sturz spontan und uebereinstimmend zum Hergang geaeussert hat.

Formathinweis: Dieses Aktenstueck wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschliesslich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Antrag auf Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Domfreihof 6, 54290 Trier

1. Antrag

Namens und im Auftrag des Herrn Karsten Moeller wird Akteneinsicht in die vollstaendige Verwaltungsakte zum Vorgang BGHW-2026-350118-MOELLER beantragt, einschliesslich aller internen Vermerke, des Wartungsbuchs Rampe 4, des Kameraausfallprotokolls und der Betriebspruefungsunterlagen, soweit diese beigezogen wurden.

2. Rechtsgrundlage

Der Antrag stuetzt sich auf Paragraf 25 SGB X. Als Beteiligter im Sinne von Paragraf 12 SGB X hat der Mandant ein Recht auf Einsicht in die ihn betreffenden Akten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung seiner rechtlichen Interessen erforderlich ist.

3. Antwort der Berufsgenossenschaft

Mit Schreiben vom 06.05.2026 gewaehrte die Berufsgenossenschaft Akteneinsicht in Form einer elektronischen Aktenkopie. Das uebersandte Wartungsbuch enthielt lediglich die Eintraege ab Januar 2026; ein handschriftlicher Vermerk der Betriebsleiterin vom 05.04.2026 zur Schwergaengigkeit der Rampe war nicht Bestandteil der uebersandten Unterlagen.

4. Nachforderung

Mit weiterem Schreiben vom 12.05.2026 wurde die vollstaendige interne Korrespondenz der MoselLogistik GmbH mit der Berufsgenossenschaft angefordert, insbesondere die E-Mail der Betriebsleiterin Jana Probst vom 05.04.2026.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlicb dezimaler Gliederung ausgegeben.

Anhoerungsschreiben der Berufsgenossenschaft

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Loebstrasse 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MOELLER

Datum: 28.05.2026

1. Beabsichtigte Entscheidung

Die Berufsgenossenschaft teilt mit, dass nach Auswertung der D-Arzt-Berichte, des MRT-Befundes und der betrieblichen Unfallanzeige beabsichtigt ist, die Anerkennung eines Arbeitsunfalls abzulehnen, da ein von aussen auf den Koerper einwirkendes Ereignis nicht im Sinne des Vollbeweises nachgewiesen sei und die Schulterverletzung ueberwiegend degenerativ erklarbar erscheine.

2. Gelegenheit zur Stellungnahme

Dem Mandanten wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen ab Zugang zu den beabsichtigten Feststellungen Stellung zu nehmen und ergaenzende Beweismittel vorzulegen.

3. Stellungnahme der Kanzlei vom 10.06.2026

Die Kanzlei verweist auf die Zeugenaussagen von Bastian Kopp und Sandra Lehnert, das Wartungsbuch mit mehrfachen Eintraegen zur Schwergaengigkeit der Rampe, den Kameraausfall im fraglichen Zeitraum sowie den intraoperativen Befund mit frischem Rupturrand. Es wird um Beruecksichtigung dieser Umstaende vor Erlass des Bescheids gebeten.

4. Ergebnis

Die Berufsgenossenschaft erliess trotz der Stellungnahme am 18.06.2026 den Ablehnungsbescheid, ohne die vorgebrachten Gesichtspunkte nach Einschaeztung der Kanzlei angemessen zu wuerdigen.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlic dezimaler Gliederung ausgegeben.

Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft, ausformulierte Vollversion

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Loebstrasse 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MOELLER

Datum: 18.06.2026

1. Bescheidtenor

Die Anerkennung des Ereignisses vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall wird abgelehnt. Ein Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere Heilbehandlung, Verletztengeld und Verletztenrente, besteht nicht.

2. Sachverhalt

Der Versicherte gibt an, am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr beim Loesen einer klemmenden Ueberladebruecke an Rampe 4 gestuerzt zu sein. Zeugen des unmittelbaren Sturzvorgangs liegen nicht vor. Die Videoaufzeichnung der betreffenden Kamera war im fraglichen Zeitraum unterbrochen.

3. Rechtliche Wuerdigung

Nach Paragraph 8 Absatz 1 SGB VII ist Arbeitsunfall ein zeitlich begrenztes, von aussen auf den Koerper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden fuehrt und das im Vollbeweis nachgewiesen sein muss. Die Berufsgenossenschaft sieht dieses Ereignis vorliegend nicht als hinreichend nachgewiesen an, da keine unmittelbare Beobachtung des Sturzvorgangs vorliegt und die medizinischen Befunde eine bereits vorbestehende degenerative Schaedigung der rechten Schulter zeigen.

4. Wuerdigung der medizinischen Befunde

Der MRT-Befund vom 09.04.2026 zeige eine Teilruptur der Supraspinatussehne bei ausgepraegter AC-Gelenksarthrose. Die Berufsgenossenschaft geht davon aus, dass die Ruptur ueberwiegend wahrscheinlich auf dem vorbestehenden degenerativen Schaden beruht und lediglich zufaellig anlaesslich der beruflichen Taetigkeit symptomatisch geworden sei.

5. Nicht beruecksichtigte Gesichtspunkte

Der Bescheid geht weder auf das Wartungsbuch der Rampe noch auf die uebereinstimmenden Erstangaben der Zeugen Kopp und Lehnert ein. Der Kameraausfall wird nur als technische Randnotiz erwaehnt, ohne beweisrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Das intraoperativ dokumentierte Knochenmarkoedem wird nicht diskutiert.

6. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch eingelegt werden. Der Bescheid gilt als am 22.06.2026 zugegangen; die Widerspruchsfrist endet damit am 22.07.2026.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid, Vollversion

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Fachanwaelte fuer Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich

An die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier, Aktenzeichen BGHW-2026-350118-MOELLER, per beA am 20.07.2026 uebermittelt.

1. Antrag

Namens und im Auftrag des Herrn Karsten Moeller wird gegen den Bescheid vom 18.06.2026, zugegangen am 22.06.2026, form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt. Beantragt wird, den Bescheid aufzuheben und das Ereignis vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall im Sinne von Paragraf 8 SGB VII anzuerkennen sowie die gesetzlich geschuldeten Leistungen, insbesondere Heilbehandlung und Verletztengeld, zu gewaehren.

2. Sachverhalt aus Sicht des Widerspruchsfuehrers

Herr Moeller uebte bei dem Ereignis eine versicherte Taetigkeit aus, indem er eine betrieblich benoetigte, klemmende Ueberladebruecke an Rampe 4 zu sichern versuchte, um den Wareneingang eines wartenden Lastzugs zu ermoeeglichen. Der Sturz erfolgte zeitlich begrenzt und wirkte von aussen auf den Koerper ein.

3. Beweiswuerdigung

3.1 Zeugenangaben

Die Zeugen Bastian Kopp und Sandra Lehnert bestaetigen unabhaengig voneinander, dass Herr Moeller sich unmittelbar nach dem Sturz zum technischen Versagen der Rampe geaeussert hat und dass die Rampe im relevanten Zeitraum wiederholt schwergaengig war.

3.2 Wartungsbuch und technischer Zustand

Nach dem Wartungsbuch wurde die Bruecke im Maerz 2026 mindestens dreimal als schwergaengig vermerkt, ein Reparaturtermin war fuer den 8. April 2026 bereits vereinbart. Diese Dokumentation stuetzt die Darstellung eines technischen Defekts als Ausloeser des Sturzes.

3.3 Kameraausfall

Der zeitlich mit dem Unfallereignis zusammenfallende Ausfall der Kamera an Rampe 4 spricht nicht gegen, sondern ist neutral zu werten; er darf nicht zu Lasten des Versicherten gewuerdigt werden, da der Ausfall unstreitig technische, nicht in der Sphaere des Mandanten liegende Ursachen hatte.

3.4 Medizinische Befunde

Der intraoperative Befund vom 21.04.2026 dokumentiert einen frischen, blutig imbibierten Rupturrand, der nach der Einschaetzung des Operateurs eine akute traumatische Komponente auf vorbestehender degenerativer Struktur belegt. Das im MRT nachgewiesene Knochenmarkoedem am Tuberculum majus ist ein typisches Zeichen einer frischen knoechernen Belastungsreaktion.

4. Rechtliche Bewertung

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, unter anderem B 2 U 4/18 R, genuegt fuer den Nachweis des Unfallereignisses der Vollbeweis anhand einer Gesamtwuerdigung aller Umstaende; eine

unmittelbare Beobachtung ist nicht zwingend erforderlich, wenn sich aus Indizien ein schlussiges Gesamtbild ergibt. Auch bei vorbestehendem Gesundheitsschaden genuegt es, wenn das Unfallereignis eine wesentliche Teilursache im Sinne der im Sozialrecht geltenden Kausalitaetslehre der wesentlichen Bedingung darstellt.

5. Beweisantraege

Es wird beantragt, das vollstaendige Wartungsbuch Rampe 4 fuer die Monate Februar bis April 2026 beizuziehen, die Zeugen Kopp, Lehnert und Nauheim erneut unter Vorhalt der ergaenzenden Unterlagen zu befragen sowie ein unfallchirurgisches Zusammenhangsgutachten einzuholen.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlicb dezimaler Gliederung ausgegeben.

Widerspruchsbescheid der Berufsgenossenschaft

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Loebstrasse 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MOELLER

Datum: 25.09.2026

1. Entscheidung

Der Widerspruch des Herrn Karsten Moeller gegen den Bescheid vom 18.06.2026 wird zurueckgewiesen.

2. Begruendung

Die Widerspruchsstelle haelt nach erneuter Pruefung an ihrer Auffassung fest, dass der Vollbeweis eines von aussen einwirkenden Ereignisses nicht erbracht sei. Die vorgelegten Zeugenaussagen beschaenken sich auf Wahrnehmungen vor und nach dem eigentlichen Sturz, nicht auf den Sturz selbst. Das Wartungsbuch belege zwar technische Maengel, lasse aber offen, ob diese ursaechlich fuer den konkreten Sturz waren oder ob der Versicherte aus anderen Gruenden das Gleichgewicht verlor.

3. Auseinandersetzung mit dem medizinischen Vorbringen

Der intraoperative Befund werde zur Kenntnis genommen, aendere aber nichts an der Einschaeztung, dass angesichts der erheblichen degenerativen Vorsaedigung eine ueberwiegende Wahrscheinlichkeit fuer eine schicksalhafte, nicht unfallbedingte Ursache der Ruptur bestehe.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Klage beim Sozialgericht Trier erhoben werden.

Formathinweis: Dieses Aktenstueck wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschliesslich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Klageschrift zum Sozialgericht Trier

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Fachanwaelte fuer Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich

An das Sozialgericht Trier, Kutzbachstrasse 3a, 54290 Trier, per beA am 20.10.2026 eingereicht.

1. Parteien

Klaeger: Karsten Moeller, Hafenstrasse nahe Trier-Ehrang wohnhaft, vertreten durch die Kanzlei Lindenhof und Partner mbB. Beklagte: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier.

2. Klageantrag

Es wird beantragt, den Bescheid vom 18.06.2026 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 25.09.2026 aufzuheben und festzustellen, dass das Ereignis vom 03.04.2026 ein Arbeitsunfall im Sinne von Paragraph 8 SGB VII ist, sowie die Beklagte zu verurteilen, die gesetzlichen Leistungen der Unfallversicherung zu gewaehren.

3. Klagebegruendung

Zur Begruendung wird auf den ausfuehrlichen Widerspruch vom 20.07.2026 und die dort dargestellte Beweislage verwiesen. Ergaenzend wird darauf hingewiesen, dass die Beklagte den Beweiswert der uebereinstimmenden Zeugenangaben unzureichend gewuerdigt und dem Kameraausfall zu Unrecht eine dem Klaeger nachteilige Bedeutung beigemessen hat.

4. Beweisantritt

Es wird die Einholung eines unfallchirurgischen Zusammenhangsgutachtens beantragt, ferner die zeugenschaftliche Vernehmung von Bastian Kopp, Sandra Lehnert und Herbert Nauheim sowie die Beiziehung des vollstaendigen Wartungsbuchs Rampe 4.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Klageerwiderung der Berufsgenossenschaft

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Loebstrasse 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MOELLER

An das Sozialgericht Trier, Az. S 4 U 88/26, Erwiderung vom 25.11.2026.

1. Antrag

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

2. Erwiderung in der Sache

Die Beklagte haelt an ihrer im Widerspruchsbescheid dargelegten Auffassung fest. Ergaenzend wird vorgetragen, dass Herr Moeller nach der internen Arbeitsanweisung Nr. 14 nicht zur eigenhaendigen Wartung der Ueberladebruecke befugt gewesen sei; ein Verstoss gegen innerbetriebliche Anweisungen koenne den Zusammenhang mit der versicherten Taetigkeit infrage stellen.

3. Stellungnahme zu den Beweisantraegen

Gegen die Einholung eines Sachverstaendigengutachtens bestehen keine grundsaeztlichen Einwaende; die Beklagte behaelt sich vor, nach Vorlage des Gutachtens ergaenzend Stellung zu nehmen. Die erneute Vernehmung der bereits im Verwaltungsverfahren gehoerten Zeugen wird fuer nicht erforderlich gehalten.

4. Hinweis zur Arbeitsanweisung

Die Beklagte legt als Anlage die interne Arbeitsanweisung Nr. 14 zur Ladungssicherung vor, wonach die Wartung technischer Rampenanlagen ausschliesslich dem Rampenwart obliegt.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlicb dezimaler Gliederung ausgegeben.

Unfallchirurgisch-orthopaedisches Zusammenhangsgutachten

Praxis fuer Unfallchirurgische Begutachtung

Prof. Dr. Matthias Sorgenfrei, Facharzt fuer Orthopaedie und Unfallchirurgie

Kaiserstrasse 2, 55116 Mainz

Gutachten im Auftrag des Sozialgerichts Trier, Az. S 4 U 88/26, erstattet am 14.01.2027 nach ambulanter Untersuchung des Klaegers am 08.01.2027.

1. Fragestellung des Gerichts

Steht die am 09.04.2026 diagnostizierte Teiltraktur der Supraspinatussehne rechts im Sinne der wesentlichen Bedingung in ursaechlichem Zusammenhang mit dem Ereignis vom 03.04.2026, oder ist sie ausschliesslich oder ueberwiegend auf die vorbestehende degenerative Schaedigung zurueckzufuehren.

2. Untersuchungsbefund

Aktive Abduktion rechts 150 Grad, Kraftgrad 4 von 5 im Seitenvergleich, endgradiger Schmerz bei Aussenrotation. Vernarbte arthroskopische Portale reizlos. Im Vergleich zur linken Schulter deutliches, aber nicht vollstaendiges funktionelles Defizit.

3. Auswertung der Aktenlage

Der Sachverstaendige wertet den geschilderten Unfallhergang, die uebereinstimmenden Erstangaben gegenueber Ersthelferin, Rettungsdienst und Durchgangsarzt, den intraoperativen Befund eines frischen Rupturrandes sowie das im MRT nachgewiesene Knochenmarkoedem als konsistentes Gesamtbild fuer eine akute traumatische Komponente.

4. Gutachterliche Einschaeztung

Der Sachverstaendige gelangt zu dem Ergebnis, dass das Ereignis vom 03.04.2026 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine wesentliche Teilursache der aufgetretenen Funktionsstoerung darstellt. Die vorbestehende degenerative Veraenderung des AC-Gelenks habe die Schulter fuer eine Verletzung anfaelliger gemacht, trete aber als Ursache des konkreten Funktionsverlusts gegenueber dem Unfallereignis nicht in den Vordergrund.

5. Einschaeztung der Minderung der Erwerbsfaehigkeit

Unter Zugrundelegung der gaengigen unfallmedizinischen Bewertungstabellen fuer Schaeden der oberen Extremitaet schaezt der Sachverstaendige die unfallbedingte Minderung der Erwerbsfaehigkeit auf der Grundlage des aktuellen Funktionsbefundes auf 20 vom Hundert ein, mit der Einschraenkung, dass eine Nachuntersuchung nach weiteren zwei Monaten zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit angezeigt ist.

Formathinweis: Dieses Aktenstueck wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschliesslich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Vorschadenshistorie, ausfuehrliche Zusammenstellung

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Domfreihof 6, 54290 Trier

1. Hausarztunterlagen 2016 bis 2018

Hausarzt Dr. Wilfried Sommerlath dokumentiert am 14.09.2016 eine Vorstellung wegen Schulterschmerzen rechts nach einem Handballspiel, verordnet wird eine kurzzeitige Schonung ohne Bildgebung. Weitere Vorstellungen am 22.05.2017 und 03.03.2018 mit aehnlichem Beschwerdebild, jeweils folgenlos ausgeheilt, keine Arbeitsunfaehigkeit laenger als drei Tage.

2. Sportliche Aktivitaet

Herr Moeller spielte bis 2018 in der Kreisliga Handball, seither nach eigenen Angaben nur noch gelegentlich Freizeitsport ohne Wettkampfbetrieb. Der Handballverein SG Trier-Ehrang bestaetigt auf Anfrage der Kanzlei, dass Herr Moeller seit der Saison 2018/2019 nicht mehr aktiv gemeldet ist.

3. Betriebsaerztliche Vorsorgeuntersuchung 2024

Die turnusmaessige Vorsorgeuntersuchung durch die Betriebsaerztin Dr. Swetlana Iwanowa am 11.03.2024 attestiert uneingeschraenkte Tauglichkeit fuer die Taetigkeit als Lagerleiter einschliesslich Hebe- und Tragetaetigkeiten bis 15 Kilogramm, keine Einschraenkung der Schulterfunktion dokumentiert.

4. Fehlzeitenauswertung

Nach der Personalakte gab es zwischen 2019 und dem Unfalltag keine einzige krankheitsbedingte Fehlzeit wegen Schulterbeschwerden. Die letzte schulterbezogene Arbeitsunfaehigkeit lag mehr als sieben Jahre zurueck.

5. Bedeutung fuer die Kausalitaetsfrage

Die Zusammenstellung soll den Vorschaden weder verschweigen noch ueberzeichnen, sondern die Beschwerdefreiheit im Alltag und Beruf in den Jahren vor dem Unfall dokumentieren, um dem Sachverstaendigen und dem Gericht eine belastbare Tatsachengrundlage fuer die Abgrenzung von Vorschaden und Unfallfolge zu liefern.

Formathinweis: Dieses Aktenstueck wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschliesslich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Berufsgenossenschaftliche Reha-Empfehlung

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Loebstrasse 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MOELLER

Erstellt vom Reha-Management der Berufsgenossenschaft am 30.06.2026, unter dem ausdruecklichen Vorbehalt der Anerkennung als Arbeitsunfall.

1. Ausgangslage

Nach dem Bericht der BG Klinik Ludwigshafen vom 22.06.2026 besteht ein relevantes Kraftdefizit der rechten Schulter, das eine Rueckkehr auf den bisherigen, koerperlich anspruchsvollen Arbeitsplatz als Lagerleiter derzeit erschwert.

2. Empfohlene Massnahmen

Empfohlen werden eine stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell ueber acht Wochen, begleitende ambulante Physiotherapie zweimal woechentlich sowie eine ergonomische Arbeitsplatzberatung durch den technischen Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft.

3. Zeitplan

4. Vorbehalt

Die Empfehlung wird ausdruecklich nur fuer den Fall ausgesprochen, dass die Anerkennung als Arbeitsunfall im Widerspruchs- oder Klageverfahren erfolgt. Bis dahin ruht die Umsetzung.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlicb dezimaler Gliederung ausgegeben.

Phase	Zeitraum	Belastung
Wiedereingliederung Stufe 1	August 2026	vier Stunden taeglich, keine Hebetaetigkeit
Wiedereingliederung Stufe 2	September 2026	sechs Stunden taeglich, Heben bis 5 Kilogramm
Wiedereingliederung Stufe 3	Oktober 2026	volle Arbeitszeit, Heben bis 10 Kilogramm unter Beobachtung

Datei: jpg/kamera_standbildbeschreibung_rampe4.jpg

Kamera Rampe 4 - Systemprotokoll (Standbild-Beschreibung, kein Originalbild)

Kamerakanal: RAMPE4_CAM_02

Status 06:28 - 06:31 Uhr: Verbindung aktiv, letztes Bild vorhanden

Status 06:31 - 07:13 Uhr: Verbindungsabbruch zum Switch, kein Bildmaterial

Status ab 07:13 Uhr: Verbindung wiederhergestellt

Angrenzende Kamera RAMPE3_CAM_01 (Randbereich, Rampe 4 nur teilweise sichtbar)

06:38 Uhr: Person mit Werkzeug auf dem Weg Richtung Rampe 4 erkennbar

07:02 Uhr: Rettungsdienstpersonal im Bildausschnitt erkennbar

Hinweis: Der eigentliche Sturzvorgang 06:38 bis 06:45 Uhr ist auf keiner verfügbaren Kameraaufzeichnung erfasst. Beschreibung erstellt durch IT-Abteilung MoselLogistik GmbH am 09.04.2026 zur Vorlage bei der Berufsgenossenschaft.

Bilddatei: kamera_standbildbeschreibung_rampe4.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/arbeitsanweisung_nr14_rampenwartung.pdf

Interne Arbeitsanweisung Nr. 14, Ladungssicherung und Rampenwartung

MosellLogistik GmbH

Qualitäts- und Sicherheitsmanagement

Hafenstrasse 28, 54293 Trier

1. Geltungsbereich

Diese Anweisung regelt die Zuständigkeiten fuer die Wartung und Fehlerbehebung an Ueberladebruecken und Rampenanlagen im Logistikzentrum Trier-Ehrang.

2. Zuständigkeit

Technische Stoerungen an Ueberladebruecken sind ausschliesslich durch den eingeteilten Rampenwart zu beheben. Schichtverantwortliche und Lagerleiter duerfen technische Anlagen nicht selbst warten oder reparieren, sondern haben Stoerungen unverzueglich an den Rampenwart oder die technische Leitstelle zu melden.

3. Meldewege

Meldungen erfolgen ueber Funk an die Disposition oder telefonisch an die technische Leitstelle. Bei akuter Betriebsbehinderung ist zusaetzlich die Schichtleitung zu informieren.

4. Stand und Freigabe

Fassung vom 12.01.2024, freigegeben durch die Geschaeftsfuehrung, gueltig bis zur naechsten Revision.